

## 17 - FMPP MOOCs - La maladie hémorroïdaire - Pr. Samlani

(0:00 - 0:11)

Bonjour, nous allons parler de la maladie hémorroïdaire. Il s'agit d'une pathologie fréquente bénigne, un véritable problème de qualité de vie. Les moyens thérapeutiques sont multiples.

(0:13 - 0:24)

Le traitement médico-instrumental a un effet suspensif. Le traitement chirurgical est radical et définitif. C'est une infection très fréquente dont l'incidence augmente avec l'âge.

(0:24 - 0:34)

Le sexe ratio est de 1. Autant d'hommes que de femmes sont touchés par les hémorroïdes. Certains facteurs de risque sont connus. On reconnaît des formes familiales.

(0:34 - 0:49)

Les hormones semblent avoir un impact, une influence sur les hémorroïdes. Il y a une recrudescence au cours de la grossesse, en postpartum, et pendant les règles, et pendant la période prémenstruelle. La constipation semble aggraver les hémorroïdes.

(0:49 - 1:23)

Les efforts de poussée, la station prolongée aux toilettes, aggravent également les hémorroïdes. Les hémorroïdes sont des formations vasculaires normales, formées par des artérioles ou des lacilles veineux, ou des chûts artérioveineux, et fixés par un tissu de soutien fibroélastique. On distingue les hémorroïdes internes, qui sont situés au-dessus de la ligne pectinée, trois paquets, antéro-droit, postéro-droit et postéro-gauche, qui participent à la continence fine, et les hémorroïdes externes, au-dessous de la ligne pectinée.

(1:24 - 1:46)

Il existe des anastomoses entre les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Sur ce schéma, vous voyez ce qu'on vient de dire, en 3 les hémorroïdes internes, en 4 les hémorroïdes externes, et en 5 la ligne pectinée. Plusieurs théories sont avancées dans la naissance des hémorroïdes.

(1:47 - 2:01)

Une théorie vasculaire. Il s'agirait d'un apport sanguin, ou un retour veineux insuffisant, qui va dépasser les capacités d'adaptation du tissu hémorroïde. Ce qui va entraîner une congestion du plexus hémorroïdaire.

(2:02 - 2:29)

La théorie mécanique est due à une faiblesse du tissu de soutien fibro-élastique. Nous allons maintenant procéder à une étude clinique des différents aspects de la maladie hémorroïdaire. Les tableaux sont variables, en fonction du type de l'hémorroïde, interne ou externe, ou de l'existence d'une complication, douleur, rectoragie, ou prolapsus hémorroïdaire extériorisé.

(2:31 - 2:46)

L'examen clinique comprend une inspection, un toucher rectal, et une anoscopie. Il doit être fait dans un environnement bienveillant, en respectant l'intimité du patient. Il ne faut surtout pas faire mal au patient.

(2:50 - 3:10)

Cet examen proctologique initial pourra être complété par la suite, par une rectoscopie et une coloscopie. Le message important, c'est que face à des rectoragies, il ne faut pas s'arrêter à des hémorroïdes. Il faudra toujours explorer plus loin pour éliminer un cancer.

(3:13 - 3:40)

Il faudra toujours faire un interrogatoire, complété par un examen clinique minutieux, pensé à faire une coloscopie pour éliminer un cancer. Les hémorroïdes demeureront toujours ce qu'on appelle un diagnostic d'élimination. La présentation clinique dépendra du type d'hémorroïde, qu'elle soit externe ou interne.

(3:42 - 4:02)

Les hémorroïdes externes peuvent être asymptomatiques. Lorsqu'une thrombose hémorroïdaire externe survient, elle est bruyante. Le début est brutal, la douleur est permanente, et à l'examen on retrouve une tumefaction bleuâtre et démaciée sur le versant externe de la marge anal, et la palpation est extrêmement douloureuse.

(4:04 - 4:36)

L'évolution spontanée de cette thrombose peut être la régression de la douleur en quelques jours, voire l'évacuation spontanée du caillot, avec persistance d'une petite marisque séquellaire, qui est une petite poche de peau, qui peut persister. La thrombose peut rester, et dans ce cas-là, on doit traiter médicalement avec des anti-inflammatoires, voire même parfois intervenir en incisant ou en excisant. On va voir ça dans le chapitre traitement.

(4:37 - 5:30)

Les principaux diagnostics différentiels sont les marisques, qui sont les petites poches de peau,

les condylomes, qui sont des excroissances dues à HPV, Human Papilloma Virus, les abcès de la marge anal, et les mélanomes. Vous voyez ici un aspect de thrombose hémorroïdaire, en bas à droite un aspect de tumefaction bleutée, et en haut à droite, une thrombose en préévacuation. Concernant les hémorroïdes internes, elles peuvent se manifester soit par la douleur, la douleur hémorroïdaire, qui va se manifester par la crise hémorroïdaire, dite fluxionnaire, soit par la thrombose hémorroïdaire, comme elles peuvent se manifester par des rectoragies ou bien par le prolapsus.

(5:33 - 6:19)

La crise fluxionnaire se revient généralement dans un contexte particulier, soit de troubles de transit, à titre de constipation, de diarrhée, de facteurs hormonaux, de menstruation, ou lors d'excès alimentaire, de prix de certains aliments, d'épices, de prix d'alcool. Dans ce cas-là, les douleurs anales sont à titre de pesanteur, et le patient perçoit une tumefaction anal. Au cours des hémorroïdes internes, la thrombose hémorroïdaire anal va se manifester par une douleur anal intense, dite invalidante, et l'examen va retrouver des hémorroïdes internes procidentes, tumefiées, irréductibles, avec parfois une zone noirâtre, ulcérée.

(6:20 - 6:50)

On peut retrouver une rétention aiguë d'urine, et l'évolution peut être spontanément favorable en quelques jours, mais parfois, elle peut l'être moins, et ça peut nécessiter une intervention médicale, voire même chirurgicale. Les hémorroïdes internes vont se manifester également par des rectoragies. Ce sont des rectoragies à la fin des selles.

(6:51 - 7:21)

Comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des rectoragies qui doivent faire éliminer une autre étiologie, notamment un cancer, mais également une rectite. Dernière manifestation des hémorroïdes internes, le prolapsus hémorroïdaire, c'est la conséquence de la cité du tissu de soutien. Il y aura une extériorisation des hémorroïdes internes avec une procidence hémorroïdaire qui va se manifester par des suetements, un prurite anal, et une perception d'une tuméfaction anal.

(7:24 - 7:42)

Ceci est un prolapsus hémorroïdaire trombosé. Les principaux diagnoses différentielles devant une douleur anal, on pense à une fissure anal, un abcès, une anite, une névragie anorectale. Devant une rectoragie, on craint un cancer.

(7:42 - 8:01)

C'est pour ça qu'il est systématique de faire une rectoscopie, ou de réaliser une coloscopie. Devant un prolapsus hémorroïdaire, on pense à un prolapsus rectal, un condylome anal, ou un

tumeur rectal extériorisé. Voici à quoi ressemble un prolapsus rectal.

(8:01 - 8:15)

Regardez cette muqueuse qui est rosée, qui est différente de la muqueuse vue précédemment. Nous allons voir maintenant le traitement des hémorroïdes. Nous disposons de trois types de traitements.

(8:16 - 8:44)

Le traitement médical, le traitement instrumental, et le traitement chirurgical. Parmi les éléments du traitement médical, les régulateurs du transit, les laxatifs, les vénotoniques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, si contre-indication au premier, les anthalgiques, et les topiclidocainés, qui peuvent aider dans les manifestations aiguës. Pour le traitement instrumental, c'est un traitement qui est suspensif.

(8:44 - 9:03)

Il a pour principe d'induire une fibre cicatricielle qui va fixer le tissu hémorroïdaire en diminuant sa vascularisation. Trois traitements instrumentaux sont validés actuellement. Ce sont les injections sclérosantes, la ligature élastique, et le traitement par infrarouge.

(9:04 - 9:25)

La principale contre-indication est la thrombose hémorroïdaire. Ce que vous voyez ici, à gauche c'est un plateau avec l'anuscopie, l'aiguille, et le produit sclérosant. Et donc, à droite, vous voyez le produit qui est injecté dans l'hémorroïde.

(9:26 - 9:50)

Ici, c'est un appareil aspiration pour ligature élastique, anuscopie, élastique, et les paquets hémorroïdaires qui seront aspirés avec pose d'élastique pour réalisation à ligature élastique. Troisième technique, c'est l'infrarouge. Vous voyez ici la réalisation de pastilles d'infrarouge.

(9:50 - 10:16)

Pour le traitement chirurgical, l'hémorroïdectomie pédiculaire ouvert selon Milligan-Morgan est le traitement le plus utilisé. De nouvelles méthodes, telles que l'hémorroïdopexie par agrafage selon Longo, ou la ligature Doppler-Aquité des artères hémorroïdaires sont de plus en plus utilisées. Vous voyez ici la technique d'hémorroïdectomie pédiculaire selon Milligan-Morgan.

(10:19 - 10:44)

Et là, vous voyez la technique d'hémorroïdopexie par agrafage selon Longo. Vous voyez comment la pince est posée et comment est-ce que l'agrafage est réalisé et l'intervention est

finalisée. La ligature épexie sous hale Doppler consiste à repérer à l'aide d'une sonde Doppler les artères hémorroïdaires et à les utiliser.

(10:47 - 11:17)

Les autres moyens thérapeutiques qui ne sont pas négligeables sont les excisions et les incisions de thrombose sous anesthésie locale. Après avoir énuméré les différents traitements, il convient d'en voir les indications. Les indications des traitements instrumentaux sont essentiellement les hémorroïdes internes symptomatiques de rectoragie, de prolapsus réductible après échec du traitement médical.

(11:18 - 11:37)

Pour la chirurgie, elle est indiquée en cas de prolapsus hémorroïdaire non réductible circulaire. Elle est indiquée également en cas de résistance au traitement médical et instrumental. Pour ce qui est des incisions de thrombose, elles sont indiquées en cas de thrombose externe.

(11:38 - 11:50)

En conclusion, les hémorroïdes sont fréquentes, le diagnostic clinique s'indirigit d'élimination, le traitement est symptomatique fonction des symptômes, il faut être le moins invasive possible.